“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECOMIENTO DE LA DEMOCRACIA”

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “LA PONTIFICIA”

CARRERA: ENFERMERIA TÉCNICA

INFORME:

INTEGRANTES

FLORES VARGAS, Sheyla Keyla

DOCENTE:

MENDOZA GUZMAN, César A.

CURSO:

Asistencia en Adulto Mayor

AYACUCHO-PERÚ

2025

Tabla de contenido

BIOGRAFÍA 5

1. CAMBIOS ANATÓMICOS Y FISIOLÓGICOS DEL ENVEJECIMIENTO 6

2. SISTEMAS SENSORIALES 6

2.1. Visión 6

2.2. Audición 6

2.3. Gusto 6

2.4. Olfato 7

2.5. Tacto 7

3. CAMBIOS EN LOS SISTEMAS Y APARATOS 7

3.1. Sistema muscular 7

3.2. Sistema esquelético y articulaciones 7

3.3. Sistema respiratorio 7

3.4. Sistema cardiovascular 8

3.5. Sistema excretor 8

3.6. Sistema nervioso 8

3.7. Sistema endocrino 8

4. CAMBIOS PSICOLÓGICOS DEL ENVEJECIMIENTO 9

4.1. Memoria 9

4.2. Atención 9

4.3. Inteligencia 9

4.4. Creatividad 9

4.5. Lenguaje 9

CAMBIOS SOCIALES EN EL ADULTO MAYOR 10

5. Cambios en el rol individual 10
5.1. Viudez 10
5.2. Soledad 10
5.3. Plan de vida 10
5.4. Familia 10
5.5. Jubilación 10
5.6. Aislamiento 10
5.7. Red 11
5.8. Vínculo 11
6. PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 11
6.1. ¿Qué es la vejez? 11
7. ETAPAS DE LA VEJEZ 11
7.1. Prevejez 11
7.2. Vejez 11
7.3. Ancianidad 12
8. EL ENVEJECIMIENTO 12
9. TIPOS DE ENVEJECIMIENTO 12
10. PACIENTE: Envejecimiento exitoso 12
11. 7 HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE PARA UN ENVEJECIMIENTO 13
11.1. EXITOSO 13
11.2. Actividad social 13
11.3. Correcta higiene 13
11.4. Evitar cigarro y alcohol 13
11.5. Actividad física 13
11.6. Alimentación saludable 13
11.7. Sentido por la vida 14
11.8. Acompañamiento afectivo 14

12. TEORÍA DEL CUIDADO 14
12.1. Teoría del Autocuidado 14
12.2. En el caso de la paciente: 14
12.3. Teoría del Déficit de Autocuidado 14
12.4. Teoría de los Sistemas de Enfermería 15
13. TIPOS DE AUTOCUIDADO 15
13.1. Autocuidado emocional 15
13.2. Autocuidado físico 15
13.3. Autocuidado cognitivo 15
13.4. Autocuidado social 15
13.5. Autocuidado espiritual 16
14. EVIDENCIAS 16

BIOGRAFÍA

La señora URBANO ROMERO Lucía de 72 años, viuda y madre de cinco hijos, con quienes vive actualmente. A lo largo de su vida se dedicó con responsabilidad y amor a su familia, desempeñando un papel fundamental en la crianza y formación de sus hijos. Se caracteriza por ser una persona alegre, sociable y colaboradora. Mantiene una buena relación con sus vecinos y disfruta participar en reuniones familiares y actividades cotidianas que le permiten mantenerse activa.

En cuanto a su salud, es una paciente aparentemente sana, sin enfermedades diagnosticadas. Presenta cambios físicos normales propios de la edad, como menor fuerza y movilidad más lenta, pero conserva su independencia y autonomía en sus actividades diarias.

A pesar de la pérdida de su esposo, ha logrado adaptarse a esta etapa de su vida con el apoyo de sus hijos y su entorno cercano, manteniendo una actitud positiva y estable emocionalmente.

1. CAMBIOS ANATÓMICOS Y FISIOLÓGICOS DEL ENVEJECIMIENTO

Los cambios anatómicos y fisiológicos del envejecimiento son modificaciones naturales que ocurren progresivamente con el paso de los años. El organismo pierde fuerza, elasticidad y capacidad de respuesta, y los órganos disminuyen ligeramente su funcionalidad. Aunque estos cambios son propios de la edad, no necesariamente implican enfermedad. En el caso de la paciente adulta mayor, se encuentra aparentemente sana, sin patologías diagnosticadas.

2. SISTEMAS SENSORIALES

2.1. Visión

La visión permite percibir el entorno y realizar actividades diarias. En la paciente adulta mayor pueden presentarse cambios normales del envejecimiento:

Disminución de la agudeza visual.

Dificultad para ver objetos de cerca.

Problemas para adaptarse a cambios bruscos de luz.

2.2. Audición

La audición es fundamental para la comunicación. En la paciente se observa:

Dificultad para percibir sonidos agudos.

Necesidad de que le hablen con mayor claridad o volumen.

Leve dificultad para comprender conversaciones en ambientes ruidosos.

2.3. Gusto

El sentido del gusto permite diferenciar sabores. Con el envejecimiento puede disminuir:

Reducción en la identificación de sabores.

Mayor dificultad para percibir lo dulce y lo salado.

Leve disminución del interés por ciertos alimentos.

2.4. Olfato

El olfato está relacionado con el apetito y la percepción del entorno.

Disminución progresiva en la identificación de olores.

Menor percepción de olores intensos.

Puede influir ligeramente en el apetito.

2.5. Tacto

El tacto permite percibir temperatura, dolor y presión.

Menor sensibilidad en manos y pies.

Dificultad para percibir cambios extremos de frío y calor.

Piel más delgada y frágil.

3. CAMBIOS EN LOS SISTEMAS Y APARATOS

3.1. Sistema muscular

La paciente refiere que su fuerza no es la misma que en años anteriores.

Disminución de masa muscular.

Cansancio al realizar actividades prolongadas.

Menor resistencia física.

3.2. Sistema esquelético y articulaciones

Rigidez leve al levantarse.

Movimientos más lentos.

Disminución leve del equilibrio.

Mayor cuidado para evitar caídas.

3.3. Sistema respiratorio

Disminución ligera de la capacidad pulmonar.

Menor elasticidad de los pulmones.

Fatiga leve ante esfuerzos intensos.

3.4. Sistema cardiovascular

Disminución leve de la elasticidad de los vasos sanguíneos.

Ritmo cardíaco más lento en reposo.

Cansancio moderado ante actividad intensa.

Sin antecedentes de enfermedad cardíaca.

Sistema digestivo

Digestión más lenta.

Posible tendencia ocasional al estreñimiento.

Mantiene apetito adecuado.

3.5. Sistema excretor

Disminución progresiva de la función renal.

Mayor frecuencia urinaria.

Mayor sensibilidad a la deshidratación.

3.6. Sistema nervioso

Respuesta más lenta a estímulos.

Reflejos ligeramente disminuidos.

Orientación conservada en tiempo, espacio y persona.

Estado emocional estable y actitud alegre.

3.7. Sistema endocrino

Metabolismo más lento.

Cambios hormonales propios de la edad.

Tendencia a variaciones de peso si no mantiene hábitos saludables.

4. CAMBIOS PSICOLÓGICOS DEL ENVEJECIMIENTO

4.1. Memoria

Memoria a largo plazo conservada.

Leves olvidos en memoria reciente.

Ejemplo: Recuerda acontecimientos importantes de su juventud, pero ocasionalmente olvida dónde dejó algún objeto.

4.2. Atención

Leve disminución de la concentración en ambientes ruidosos.

Necesita más tiempo para procesar información.

4.3. Inteligencia

Inteligencia basada en la experiencia conservada.

Buen juicio y razonamiento práctico.

4.4. Creatividad

Conservada y activa.

Participa en actividades familiares y comunitarias.

4.5. Lenguaje

Comunicación clara.

Puede tardar algunos segundos en encontrar palabras específicas.

CAMBIOS SOCIALES EN EL ADULTO MAYOR

5. Cambios en el rol individual

5.1. Viudez

La paciente atravesó la pérdida de su cónyuge, experiencia que representó un proceso de duelo y reajuste emocional. Actualmente demuestra adecuada adaptación, favorecida por el acompañamiento y apoyo constante de su entorno familiar.

5.2. Soledad

Si bien pueden presentarse episodios ocasionales de nostalgia, no se evidencia aislamiento social, ya que convive con sus cinco hijos y mantiene interacción frecuente con vecinos y personas de su comunidad.

5.3. Plan de vida

Algunos proyectos personales pudieron haberse modificado con el paso del tiempo; sin embargo, mantiene metas acordes a su etapa vital, orientadas a conservar su participación activa dentro del entorno familiar y social.

5.4. Familia

La familia constituye un pilar fundamental en su bienestar.

Reside con sus cinco hijos.

Recibe apoyo emocional y compañía permanente.

Continúa ejerciendo un rol orientador y de consejo dentro del hogar.

Cambios en el rol social

5.5. Jubilación

En esta etapa organiza su tiempo en actividades personales, familiares y recreativas, adaptándose a un ritmo de vida menos demandante.

5.6. Aislamiento social

No presenta signos de aislamiento, ya que conserva relaciones interpersonales estables y participa activamente en su entorno.

5.7. Red social

Dispone de una red de apoyo compuesta por hijos, vecinos y amistades, lo cual fortalece su estabilidad emocional y calidad de vida.

5.8. Vínculo social

Es reconocida como una persona sociable, colaboradora y participativa, manteniendo vínculos afectivos saludables que favorecen su integración comunitaria.

6. PROCESO DE ENVEJECIMIENTO

6.1. ¿Qué es la vejez?

La vejez es la última etapa del desarrollo humano, que generalmente comienza a partir de los 60 o 65 años, dependiendo del contexto social y biológico. Se caracteriza por la presencia de cambios fisiológicos, disminución progresiva de algunas capacidades funcionales y modificaciones en los roles sociales. Sin embargo, la vejez no es sinónimo de enfermedad o dependencia, ya que muchas personas mantienen autonomía e independencia.

7. ETAPAS DE LA VEJEZ

7.1. Prevejez

Comprende aproximadamente entre los 60 y 74 años.

En esta etapa los cambios físicos comienzan a hacerse más evidentes, pero la persona suele mantener independencia funcional, participación social activa y estabilidad emocional.

7.2. Vejez

Se sitúa aproximadamente entre los 75 y 84 años.

Puede presentarse mayor disminución de la capacidad física, aumento del riesgo de enfermedades crónicas y necesidad ocasional de apoyo en algunas actividades.

7.3. Ancianidad

Corresponde generalmente a los 85 años en adelante.

Se caracteriza por mayor vulnerabilidad física, posible dependencia parcial o total y aumento del riesgo de fragilidad.

8. EL ENVEJECIMIENTO

El envejecimiento es el conjunto de cambios estructurales y funcionales que ocurren en el organismo con el paso del tiempo. Afecta todos los sistemas corporales y está influenciado por factores genéticos, ambientales, sociales y estilos de vida.

9. TIPOS DE ENVEJECIMIENTO

Existen tres principales clasificaciones:

Envejecimiento exitoso

Envejecimiento usual

Envejecimiento con fragilidad

10. PACIENTE: Envejecimiento exitoso

El envejecimiento exitoso se caracteriza por la conservación de la capacidad funcional, ausencia de enfermedades graves, autonomía en las actividades diarias y participación activa en el entorno social.

En el caso de la paciente:

Se encuentra aparentemente sana.

Mantiene independencia en sus actividades.

Vive con sus cinco hijos y cuenta con apoyo familiar.

Conserva estabilidad emocional tras la viudez.

Mantiene interacción social con vecinos y comunidad.

11. 7 HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE PARA UN ENVEJECIMIENTO

11.1. EXITOSO

El caso de la paciente evidencia características propias de un envejecimiento exitoso, ya que mantiene autonomía, estabilidad emocional y adecuada integración social. A continuación, se relacionan los hábitos saludables con su situación actual:

11.2. Actividad social

La paciente mantiene interacción constante con sus cinco hijos y vecinos. Participa en reuniones familiares y conversaciones cotidianas, lo que fortalece su salud mental, previene el aislamiento y favorece su bienestar emocional.

11.3. Correcta higiene

Conserva independencia en sus actividades básicas de la vida diaria, incluyendo el autocuidado. Mantiene adecuada higiene personal, lo que previene enfermedades y contribuye a su autoestima y bienestar físico.

11.4. Evitar cigarro y alcohol

No presenta hábitos nocivos como consumo de tabaco o alcohol, lo que reduce el riesgo de enfermedades crónicas y favorece la conservación de sus funciones orgánicas.

11.5. Actividad física

Aunque presenta cambios normales propios de la edad, se mantiene activa dentro del hogar y en su entorno social. La movilidad constante en sus actividades cotidianas contribuye a preservar su fuerza muscular y equilibrio.

11.6. Alimentación saludable

Mantiene un apetito adecuado y hábitos alimenticios estables, lo que favorece su estado nutricional y previene complicaciones metabólicas.

11.7. Sentido por la vida

A pesar de la viudez, conserva una actitud positiva y metas acordes a su etapa vital. Encuentra motivación en la convivencia con sus hijos y en su participación familiar, lo que fortalece su estabilidad emocional.

11.8. Acompañamiento afectivo

Vive con sus cinco hijos, quienes le brindan apoyo emocional y compañía permanente. Este entorno afectivo estable reduce el riesgo de depresión y favorece su adaptación al proceso de envejecimiento.

12. TEORÍA DEL CUIDADO

12.1. Teoría del Autocuidado

Según la teoría propuesta por Dorothea Orem, el autocuidado es la capacidad que tiene la persona para realizar actividades orientadas a mantener su salud y bienestar.

12.2. En el caso de la paciente:

Mantiene independencia en sus actividades básicas (higiene, alimentación y movilidad).

Conserva autonomía funcional.

Presenta capacidad para tomar decisiones relacionadas con su salud.

Por lo tanto, demuestra adecuada capacidad de autocuidado acorde a su edad.

12.3. Teoría del Déficit de Autocuidado

No se evidencia un déficit significativo de autocuidado, ya que la paciente es funcional y aparentemente sana. Sin embargo, debido a los cambios fisiológicos propios del envejecimiento (disminución de fuerza, menor agudeza visual, ligera rigidez articular), el profesional de enfermería debe realizar seguimiento preventivo para evitar futuras limitaciones.

12.4. Teoría de los Sistemas de Enfermería

En este caso corresponde el Sistema de Apoyo-Educación, ya que:

La paciente es capaz de realizar su autocuidado.

Solo requiere orientación sobre hábitos saludables.

Se beneficia de educación para la prevención de riesgos (caídas, deshidratación, sedentarismo).

El rol de enfermería se centra en la promoción de la salud y prevención de complicaciones.

13. TIPOS DE AUTOCUIDADO

13.1. Autocuidado emocional

La paciente ha logrado adaptarse al proceso de viudez, manteniendo estabilidad emocional. Expresa actitud positiva y recibe apoyo afectivo de sus hijos, lo que favorece su bienestar psicológico.

13.2. Autocuidado físico

Mantiene hábitos adecuados de higiene, alimentación y movilidad dentro del hogar. Aunque presenta cambios normales de la edad, conserva autonomía en sus actividades diarias.

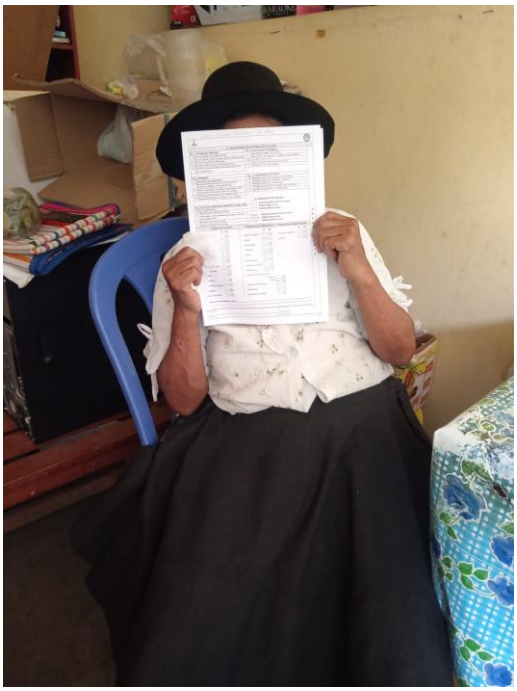
13.3. Autocuidado cognitivo

Participa en conversaciones familiares y actividades cotidianas que estimulan su memoria y atención. Conserva orientación y buen juicio basado en su experiencia.

13.4. Autocuidado social

Vive con sus cinco hijos y mantiene buena relación con sus vecinos, lo que fortalece su red de apoyo y previene el aislamiento social.

13.5. Autocuidado espiritual

Mantiene valores personales y sentido de vida a través de su rol familiar y su actitud optimista, lo que contribuye a su estabilidad emocional y satisfacción personal.

14. EVIDENCIAS: